

無症狀成人是否需要例行理學檢查？

Physical Examination for Asymptomatic Adults — NEJM Clinical Decisions

N Engl J Med 2026;395(9):923–925

謝慕揚 MD, PhD, FESC

[原文連結：doi.org/10.1056/NEJMcldc2515158](https://doi.org/10.1056/NEJMcldc2515158)

立場由編輯指派，兩個選項都不能被視為對或錯

這是什麼文體

NEJM Clinical Decisions 互動專欄

1. 給一個案例情境
↓
2. 提出兩個選項（互斥）
↓
3. 編輯「指派」兩位專家各為一方辯護
→ 立場是被指定的，不必然是作者本人的信念
↓
4. 讀者投票，形成社群意見

**讀這種文章的目的不是找答案，
而是看清楚兩邊各自站在什麼證據上。**

案例

你是社區健康中心的基層醫療醫師。

項目	內容
病人	60 歲男性 ，無任何已知慢性病，太太陪同來例行看診
病史	適齡癌症篩檢與疫苗都完成；上次看基層醫師是 好幾年前
主訴	完全沒有新問題，自覺健康良好
用藥	famotidine（偶發 GERD）、trazodone（助眠）；近期無變動
社會史	建築師；每週 2–3 份酒精飲料； 不抽菸
生命徵象	BP 126/88、HR 72、SpO₂ 98% (room air)
已決定	抽血：CBC、CMP、lipid、HbA1c、甲狀腺功能

你的決定：這次看診**要不要做例行理學檢查？**

正方

應該做例行理學檢查

Allan H. Goroll, M.D. (MGH / Harvard)

正方論點（1）：觸摸建立信任

- 《Nature Human Behaviour》2024 系統性回顧與多變量統合分析支持治療者長久以來的直覺：觸摸能促進親和感與信任
- 省略理學檢查 = 失去建立這個基礎的機會
- 透過針對性檢查回應病人的關切，傳達「你的擔心被聽見」

病人期待被檢查，不檢查會被扣分 — West Haven VA 門診 452 位健康病人研究：

對醫師的評價	回憶起的檢查動作數
評價較高	平均 8.20 項
評價較低	平均 4.44 項

正方論點（2）：檢查「不能漏掉」的徵象

這位病人**因年齡與性別**，本就是心血管疾病與癌症的較高風險族群。

針對性檢查應該找的 must-not-miss 徵象：

- 型態異常的色素性皮膚病灶
- 無痛性的後頸部或鎖骨上淋巴結腫大
- 乳房結節
- 血管雜音 (vascular bruits)
- 脈搏減弱

同時，**減少不必要檢驗與訴訟風險** — 這兩者很大一部分源自「病人覺得醫師不夠專業、不夠關心」。

正方自己承認的風險

Goroll **直接承認**：這些檢查可能導致**不必要的檢驗、焦慮與過度治療**。

他的防線：**考量脈絡 + 提高採取行動的門檻 (high threshold for action)**

他自己舉的反面教材：

USPSTF 給頸動脈狹窄篩檢 "D" (不建議) 等級，
主要理由正是——**醫師常常直接走向高風險的頸動脈血管重建，而不是單純給藥物治療。**

結論：省下低價值的行政工作，換取 **10 分鐘經過思考的針對性理學檢查**，是時間上極佳的投資。

反方

不應該做例行理學檢查

Adam S. Cifu, M.D. (University of Chicago)

反方論點 (1)：它是診斷工具，不是儀式

理學檢查是一種診斷檢測 (diagnostic test)，用來檢驗病史所產生的假說。
在無症狀成人的例行看診中，根本沒有需要被檢驗的假說。

當篩檢工具，它沒有效果：

- 一系列 **VA** 高品質系統性回顧：**不建議**對無症狀成人做全面例行理學檢查
- **Cochrane 分析 (17 個 RCT)**：一般健康檢查對降低全因死亡（含癌症與心血管死亡）**幾乎沒有效果**

反方論點（2）：低盛行率下的偽陽性

在**驗前機率極低**的人身上檢查 → 產生**偽陽性** → 陽性發現難以判讀

更糟的是，多數理學檢查發現的**敏感度與特異度都很低**：

只有 28% 的陽性理學檢查發現，具有臨床上有意義的陽性概似比 (LR+)。

造成的傷害：不必要的焦慮與花費、過度檢驗、過度診斷、過度治療

同時：把有限的臨床時間花在這裡，**進一步加重已超載的基層醫療負擔**

反方論點（3）：對「強化醫病關係」的直球反駁

有人主張理學檢查能強化治療同盟。Cifu 認為**恰恰相反**：

告訴病人「你的心血管檢查是正常的」看似令人安心，
但**如果後來被證明不是真的，反而會傷害這段關係。**
寶貴的時間應該花在**有生產力的對話**上，而不是**表演性的動作**。

醫學史上早有先例 — 已被放棄的常規檢查：

- 例行攝護腺指診
- 不需做子宮頸抹片時的例行骨盆腔內診
- 例行睪丸檢查

專注於**必要、有實證、有價值**的照護，而不是**被期待、但可能有害**的照護。

爭點對照表

爭點	正方 (Goroll)	反方 (Cifu)
檢查的本質	建立關係 + 找 must-not-miss 徵象	診斷檢測，用來檢驗假說
無症狀者的價值	抓無症狀期動脈硬化與癌症	沒有假說 → 沒有適應症
對死亡率	承認除量血壓外證據薄弱	Cochrane 17 RCT：幾乎無效
醫病關係	觸摸促進信任	假的安心被推翻會傷害關係
偽陽性	靠提高行動門檻控制	僅 28% 有意義 LR+ → 難控制
時間成本	值得投資的 10 分鐘	低價值照護，加重負擔

統計推理

為什麼「肺部囉音」的例子這麼有殺傷力

算一次驗後機率

情境：以「囉音」預測急性咳嗽病人有肺部浸潤
文獻報告的最高 $LR+ = 2.7$

在健康無症狀者身上：

驗前機率 = 0.1% (作者認為這還高估了)

↓ 套用 $LR+ = 2.7$

驗後機率 $\approx 0.27\%$

0.27% 對臨床決策毫無幫助。

你不會因為 0.27% 就開始治療；

但你**很可能**因此照一張胸部 X 光 → 偶然發現肺結節 → 電腦斷層 → 追蹤 → 焦慮.....

這就是「低價值檢查如何啟動級聯反應 (cascade)」的完整示範。

核心的貝氏教訓

高 LR + 低驗前機率 = 仍然是低驗後機率

↓

決定檢查是否有用的，永遠是「驗前機率」，
不是檢查本身有多敏感。

對心臟科同樣成立 — 在無症狀健康成人身上：

- 功能性收縮期雜音
- 輕微的下肢水腫
- 觸摸不到的足背動脈

每一個在低驗前機率下的陽性發現，都可能啟動一連串的心臟超音波、都卜勒與焦慮。

兩邊其實都同意的事

共識	說明
量血壓有價值	Goroll 明講「除量血壓外少有降低死亡率的證據」；本案 BP 126/88 本身就是資訊
「頭到腳」全面體檢沒有證據支持	Goroll 主張的是 針對性 (directed) 檢查
過度檢驗與過度診斷是真實傷害	Goroll 自己舉 USPSTF 頸動脈 "D" 級為例
基層醫療時間極度稀缺	兩人都以此為前提，只是導向不同結論
預防保健的價值在「針對性、有實證的介入」	Cifu 明確承認

真正的分歧不是「檢查 vs 不檢查」，而是「檢查的正當性來源」：
關係建立本身算不算正當理由？

心臟科醫師的視角（一）：我們也該被同樣審視

情境	貝氏思考
無症狀者的 功能性雜音	驗前機率低 → 多數不需心臟超音波
頸動脈聽診篩檢	USPSTF "D" 級 ——傷害來自「發現後傾向做血管重建」
無症狀者的 運動心電圖	同樣的低驗前機率邏輯
「順便」加做的 冠狀動脈鈣化分數	先想清楚結果會改變什麼

心臟科醫師的視角（二）：但我們的假說幾乎永遠存在

反方的論證核心是「**要有假說**」——心臟科的日常裡，假說幾乎永遠存在：

- 呼吸困難 → 頸靜脈壓、肺部囉音、S3、下肢水腫
- 新發生的雜音 → 完整瓣膜評估
- 疑似心內膜炎 → 週邊徵象（敏感度低，但驗前機率高）
- TAVI / TEER 術後 → 新雜音、心衰竭徵象、血管通路併發症

本文的論證不是反對理學檢查，而是反對「沒有假說的理學檢查」。

心臟科病人幾乎總是帶著假說來的。

台灣情境的差異

面向	美國情境	台灣情境
就診頻率	案例中「好幾年前」才看過醫師	健保可近性高，門診頻繁
看診時間	討論「省出 10 分鐘」	時間更短，壓力更大
成人健檢	以 USPSTF 建議為主軸	國健署成人預防保健服務 有給付項目
病人期待	期待被檢查	期待可能更高，常伴「順便照個超音波」
訴訟環境	壓力大	同樣存在，防禦性醫療動機明顯

務實折衷：針對性理學檢查 + 明確說明檢查理由。
做之前先問：我在檢驗什麼假說？如果陽性，我會怎麼做？

教學上怎麼用這篇

- Step 1 讀案例，先投票：做 or 不做？（不看兩篇論述）
- Step 2 分兩組各讀一方，5 分鐘後辯論
- Step 3 一起算「囉音」那題： $LR+ 2.7 \times 0.1\% \rightarrow 0.27\%$
→ 帶出貝氏定理與「驗前機率決定一切」
- Step 4 找出「兩邊都同意的事」
→ 訓練辨識真正分歧點的能力
- Step 5 轉回自己的專科：
「我今天門診做的哪些檢查是有假說的？哪些是儀式性的？」
- Step 6 再投票一次，看誰改變立場、為什麼

延伸問題：病人主動要求做完整檢查怎麼回應？「建立關係」能否單獨構成正當理由？
「提高行動門檻」實務上守得住嗎？**下一個該被放棄的常規檢查是什麼？**

Clinical Pearls

Pearl 1：**理學檢查是診斷檢測，不是儀式。做之前先問「我在檢驗什麼假說？」

Pearl 2：**驗前機率決定一切。 $LR+ 2.7 \times \text{驗前機率 } 0.1\% = \text{驗後機率 } 0.27\%$ 。

Pearl 3：只有 28% 的陽性理學檢查發現具有臨床上有意義的 LR+。

Pearl 4：USPSTF 給頸動脈篩檢 "D" 級，是因為「找到之後醫師傾向做高風險的血管重建」——傷害往往來自發現之後的行為。

Pearl 5：**兩位專家都不支持傳統的「頭到腳全面體檢」。正方主張的是針對性檢查。

參考文獻

1. Nigam M, Goroll AH, Cifu AS. Physical Examination for Asymptomatic Adults (Clinical Decisions). *N Engl J Med*. 2026;395(9):923–925.
2. Packheiser J, Hartmann H, Fredriksen K, et al. A systematic review and multivariate meta-analysis of the physical and mental health benefits of touch interventions. *Nat Hum Behav*. 2024;8:1088–1107.
3. Krogsbøll LT, Jørgensen KJ, Gøtzsche PC. General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2019;1:CD009009.
4. Duan L, Mukherjee EM, Federman DG. The physical examination: a survey of patient preferences and expectations during primary care visits. *Postgrad Med*. 2020;132:102–108.
5. Müskens JLJM, Kool RB, van Dulmen SA, Westert GP. Overuse of diagnostic testing in healthcare: a systematic review. *BMJ Qual Saf*. 2022;31:54–63.
6. USPSTF, Krist AH, Davidson KW, et al. Screening for Asymptomatic Carotid Artery Stenosis: USPSTF Recommendation Statement. *JAMA*. 2021;325:476–481.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

NEJM Clinical Decisions 2026;395(9):923–925